

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

interferon β -1a 30mcg

(아보넥스주 , 현대약품)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 프리필드시린지 중 interferon β -1a 30mcg 1품목

☐ 효능 효과 :

- 재발성 다발성 경화증의 치료

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2009년 제7차 약제급여평가위원회: 2009년 7월 24일

2009년 제13차 약제급여평가위원회: 2009년 12월 17일(재평가)

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 6월 15일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2009년 제7차 약제급여평가위원회)

○ 비급여.

- 신청품은 “재발성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로 주 3회 피하주사하는 기등재된 interferon β -1a제제에 비해 주 1회 근육주사로 투여하는 제제로서 투약의 편의성은 있을 수 있으나 기등재된 동일성분 제제(레비프주)와 효과 비교시 열등함으로 상대적인 임상적 유용성과 비용효과성이 불분명하므로 비급여함

□ 최종결과(2009년 제13차 약제급여평가위원회)

○ 기심의 유지(비급여)

- 신청품은 “재발성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로 주 3회 피하주사하는 기등재된 interferon β -1a제제에 비해 주 1회 근육주사로 투여하는 제제로서 투약의 편의성은 있을 수 있으나 기등재된 동일성분 제제(레비프주)와 효과 비교시 열등하고 중화항체의 치료적 영향이 명확하지 않은 상황임을 고려시 상대적인 임상적 유용성과 비용효과성이 불분명하므로 기심의를 유지하기로 함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하나, 현재 동일 적응증에 허가받은 interferon제제가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서¹⁾와 임상진료지침²⁾에서 다발성 경화증의 질병완화치료제 (disease modifying therapy)로 언급되고 있으며, 대체약제와의 직접비교임상연구논문³⁾에서는 신청품의 효과가 열등하였음
 - 기심의된 신청품과 대체약제를 직접비교한 임상연구논문(RCT)에서 relapse-free patient수가 대체약제는 191명(56%), 신청품은 163명(48%)이었고(P=0.023, Odds Ratio(95%CI): 1.5(1.1~2.0) 중화항체(NAB)의 경우 레비프군의 26%, 아보넥스군의 3%에서 관찰되었으며, 재발율에서는 NAB+나 NAB- 비슷하나 MRI로 측정한 질병의 활성도에서는 NAB+군이 현저히 크게 나타남³⁾
 - 다만, 교과서⁴⁾, 기심의 문헌³⁾ 및 추가 제출문헌⁵⁾, 제외국 허가사항⁶⁾등에 의하면 신청품은 대체약제에 비해 중화항체 발생율은 낮으며 중화항체 생성이 효과를 감

소시킬수는 있으나 결과에 대한 신중한 해석과 장기적인 연구가 필요하며, 중화항체와 효과간의 임상적 유용성은 불분명한 것으로 나타나 있음

- 추가 제출 문헌(open-label trial 또는 observational study 9편)에서 신청품과 대체약제의 효과는 유의한 차이가 없었으나 근거수준은 낮은 연구였음
- 신청품과 대체약제의 제3상임상시험이 포함된 SR7)에서는 신청품은 대체약제 비교시 유의한 차이가 없었음

- 기존 제제는 주 3회 피하주사하나 신청품은 주1회 근육주사하므로 주사빈도의 감소에 의한 편의성8)이 있을수 있음

○ 비용효과성

- 신청품은 동일한 유효성분인 interferon β -1a제제로서 식약청 허가시 개발목표제품인 “interferon β -1a(레비프주)”를 대체약제로 선정함
- 식약청 허가사항의 용법·용량에 근거한 투약비용 산출시 신청품은 [REDACTED] 원(1주)으로 대체약제의 [REDACTED] 원(1주)에 비해 저렴함
 - 다만, 대체약제의 실제 청구현황과 허가사항을 고려하면 대체약제의 1주 투약비용은 [REDACTED] 원임

○ 재정 영향

- 신청품 투여 대상환자수는 1차년도에 약 [REDACTED] 여명으로 예상되며, 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 1차년도 절대재정소요금액9)은 약 [REDACTED] 원이며 기존 제제(레비프주)를 대체시 재정소요금액10)은 약 [REDACTED] 원 감소될 것으로 예상됨11)
 - 다만, 대체약제 허가사항의 용법·용량 중 “고용량에 내약성이 좋지 않은 환자의 경우에는 이 약 22 μ g을 1주 3회 피하주사한다” 되어 있는 점과 실제 청구량을 고려한다면 재정절감효과는 다소 감소할 가능성이 있음

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7국가 및 호주에 등재되어 있음

Reference

- 1) Harrison's Internal Medicine(17th), Cecil Medicine, 23rded. Disease
- 2) Disease modifying therapies in multiple sclerosis: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and the MS Council for Clinical Practice Guidelines
- 3) Full results of the Evidence of Interferon Dose-Response-European North American Comparative Efficacy (EVIDENCE) study: a multicenter, randomized, assessor-blinded comparison of low-dose weekly versus high-dose, high-frequency interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis

- 4) Harrison's Internal Medicine(17th), Cecil Medicine, 23rd ed. Disease
- 5) Interferon β -1a in MS; Results following development of neutralizing antibodies in PRISMS
- 6) Interferon beta-1a Product Approval Information - Licensing Action(FDA)
- Comparative Study of Rebif to Avonex and Orphan Exclusivity (2002.3.7)
- 7) Immunomodulatory agents for the treatment of relapsing multiple sclerosis: Systemic review
Arch Intern Med 2002;161:2161-2169
- 8) 대한신경과학회의견(,)
- 9) 제약사 예상 연간 환자수 명 $\times$ 주 $\times$ 제약사 요구가 = 원
- 10) 대체고려 재정소요금액 = (대체약제의 1주 투약비용 - 신청품의 1주 투약비용) $\times$ 제약사 예상 환자수(명) $\times$ 주
- 11) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)